ANALISIS PROGRAM SIBULAN TERHADAP STATUS GIZI LANSIA MENGGUNAKAN METODE *MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT* (MNA)

Eldo Hidayat Arianto[1], Adi Irawan[2], Umi Narimawati[3]

Universitas Komputer Indonesia

E-Mail: eldo.10521017.mahasiswa.unikom.ac.id[1], adi.10521009.mahasiswa.unikom.ac.id[2], umiarie@email.unikom.ac.id[3]

ABSTRACT

Malnutrition in the elderly is a global health problem that increases the risk of morbidity and mortality. This study aimed to evaluate the nutritional status of 20 elderly people using the Mini Nutritional Assessment (MNA-LF) to identify the prevalence of malnutrition and nutritional risk. Data were collected through interviews and anthropometric measurements, including Body Mass Index (BMI), arm circumference, and calf circumference, as well as aspects such as meal frequency and mobility. The MNA score was calculated based on 18 items with a maximum total of 30 points, classified as well-nourished (≥24), at risk of malnutrition (17-23.5), and malnourished (<17). The results showed that 50% of patients (10 of 20) had good nutritional status, 30% (6 patients) were at risk of malnutrition, and 20% (4 patients) were malnourished, with weight loss and low BMI being the main determinants. Patients with a score <17 showed decreased food intake and limited mobility. In conclusion, the MNA proved effective as a screening tool for detecting malnutrition in the elderly, highlighting the need for nutritional interventions in this at-risk group. Regular monitoring and dietary supplementation are recommended to prevent health complications. Further research is needed to validate this in a larger population.

Keywords: Malnutrition, Elderly, Mini Nutritional Assessment, Nutrition Screening, Health Intervention.

ABSTRAK

Malnutrisi pada lansia merupakan masalah kesehatan global yang meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi status gizi 20 lansia menggunakan Mini Nutritional Assessment (MNA-LF) untuk mengidentifikasi prevalensi malnutrisi dan risiko gizi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengukuran antropometri, termasuk Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar lengan, dan lingkar betis, serta aspek seperti frekuensi makan dan mobilitas. Skor MNA dihitung berdasarkan 18 item dengan total maksimum 30 poin, diklasifikasikan sebagai gizi baik (≥24), risiko malnutrisi (17-23.5), dan malnutrisi (<17). Hasil menunjukkan 50% pasien (10 dari 20) memiliki status gizi baik, 30% (6 pasien) berisiko malnutrisi, dan 20% (4 pasien) mengalami malnutrisi, dengan faktor penentu utama berupa penurunan berat badan dan IMT rendah. Pasien dengan skor <17 menunjukkan penurunan asupan makanan dan mobilitas terbatas. Kesimpulan, MNA terbukti efektif sebagai alat skrining untuk mendeteksi malnutrisi pada lansia, menyoroti perlunya intervensi gizi pada kelompok berisiko. Disarankan untuk melaksanakan pemantauan rutin dan suplementasi makanan guna mencegah komplikasi kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk validasi pada populasi yang lebih besar.

Kata Kunci: Malnutrisi, Lansia, Mini Nutritional Assessment, Skrining Gizi, Intervensi Kesehatan.

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah lansia di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, menjadi fenomena demografis yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Saputro & Partinah, 2024) persentase lansia di Kota Bandung mencapai 10,60% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 10,91% pada tahun 2024. Komposisi lansia didominasi oleh kelompok usia muda (60–69 tahun) sebesar 63,88%, diikuti kelompok usia madya (70–79 tahun) sebesar 27,81%, dan kelompok usia tua (≥80 tahun) sebesar 8,31% (Partinah & Anwar, 2025). Tren ini menunjukkan bahwa jumlah lansia diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 1998), lansia didefinisikan sebagai individu berusia 60 tahun ke atas, yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak dan kesejahteraannya.

Untuk mendukung kesejahteraan lansia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Nasional (Stranas) kelanjutusiaan melalui (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, 2021). Strategi ini mencakup lima pilar, yaitu: (1) peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu, (2) peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia, (3) pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lansia, (4) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan, dan (5) penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak lansia. Di antara pilar tersebut, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup menjadi fokus utama, mengingat lansia rentan terhadap masalah gizi, seperti malnutrisi, akibat faktor usia, kesehatan, atau keterbatasan ekonomi.

Mini Nutritional Assessment (MNA) adalah alat penilaian gizi yang dirancang khusus untuk lansia, digunakan secara luas untuk mendeteksi risiko malnutrisi dan mengevaluasi status gizi secara komprehensif. MNA terdiri dari dua versi: MNA-Short Form (MNA-SF) untuk skrining cepat dalam 3–5 menit dan MNA-*Long Form* (MNA-LF) untuk penilaian mendalam dalam 10–15 menit, mencakup 18 item seperti antropometri (IMT, lingkar lengan, lingkar betis), asupan gizi (protein, buah, sayur, cairan), kesehatan umum (mobilitas, stres, masalah neuropsikologis), dan persepsi subjektif tentang gizi dan kesehatan (Setyowati et al., 2022). Penelitian oleh (Aini & Anugrahanti, 2023) di Kecamatan Poncokusumo, Malang, menunjukkan bahwa pelatihan kader kesehatan menggunakan MNA-SF meningkatkan pengetahuan tentang status gizi lansia, dengan skor *post-test* rata-rata 73,0 dibandingkan *pre-test* 60,3, memfasilitasi deteksi dini malnutrisi di komunitas. Sementara itu, MNA-LF lebih cocok untuk analisis mendalam, seperti yang digunakan untuk mengevaluasi status gizi lansia di panti sosial (Kurniadhi et al., 2023).

Program Nasi Bekal Buat Lansia (SIBULAN) di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, bertujuan meningkatkan status gizi lansia melalui pemberian makanan bergizi dan edukasi gizi. Penelitian oleh (Ariesti et al., 2022) menunjukkan bahwa pelatihan caregiver menggunakan MNA meningkatkan kemampuan skrining gizi, yang relevan untuk konteks SIBULAN. Penelitian ini menggunakan MNA-LF untuk mengevaluasi dampak SIBULAN, dengan fokus pada parameter seperti asupan protein, buah-sayur, dan kemampuan makan mandiri, yang selaras dengan tujuan program. Dengan prevalensi malnutrisi lansia yang tinggi di wilayah perkotaan (Boy, 2019), MNA-LF menjadi alat yang ideal untuk memberikan data objektif guna mendukung pengembangan kebijakan kesehatan lansia di Kecamatan Sukajadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Gizi adalah istilah yang mengacu pada zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi yang optimal. Zat-zat gizi ini mencakup makronutrien (protein, karbohidrat, dan lemak) serta mikronutrien (vitamin dan mineral). Gizi yang adekuat sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Status gizi menggambarkan kondisi seseorang atau populasi dalam hal asupan makanan dan penyerapan zat-zat gizi, serta dampaknya terhadap kesehatan dan pertumbuhan. Status gizi yang baik menunjukkan bahwa kebutuhan zat-zat gizi terpenuhi dan tubuh berfungsi dengan baik. Namun, status gizi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kurang gizi, kekurangan

vitamin dan mineral, serta obesitas (Nababan et al., 2023).

Status gizi adalah suatu keadaan kesehatan tubuh berkat asupan zat gizi melalui makanan dan minuman yang dihubungkan dengan kebutuhan. Status gizi biasanya baik dan cukup, namun karena pola konsumsi yang tidak seimbang maka timbul status gizi buruk dan status gizi lebih (Sutomo & Anggraini, 2010). Status gizi mencerminkan asupan makanan yang dikonsumsi seseorang dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ketersediaan zat gizi dalam tubuh sangat menentukan apakah kondisi gizinya tergolong kurang, cukup, atau berlebih. Asupan makanan yang diterima akan dimanfaatkan untuk mendukung proses pertumbuhan fisik, sehingga status gizi dan perkembangan tubuh dapat dijadikan indikator dalam memantau kecukupan gizi seseorang. Pertumbuhan dan kesehatan secara keseluruhan sangat bergantung pada asupan nutrisi yang memadai (Fuada et al., 2023).

Lansia atau lanjut usia merupakan fase kehidupan ketika seseorang telah mencapai kematangan secara fisik dan fungsional. Namun, masa ini juga ditandai dengan penurunan kemampuan seiring bertambahnya usia. Terdapat berbagai pendapat mengenai batasan usia lansia, ada yang menyebutkan 60 tahun, 65 tahun, atau bahkan 70 tahun. Namun, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan usia 65 tahun sebagai patokan, karena pada usia tersebut proses penuaan sudah terlihat jelas dan seseorang dapat dikategorikan sebagai lansia (Siregar & Yusuf, 2022).

Lanjut usia (lansia) merupakan periode rentang kehidupan manusia. Menghadapi periode ini sebagian lansia melewati hidupnya bersama keluarga, ada juga yang hidup sendiri karena pasangan hidup mereka sudah meninggal atau juga tidak punya sanak saudara sama sekali. Melewati masa ini, lansia memiliki kesempatan untuk berkembang mencapai pribadi yang lebih baik dan semakin matang. Lansia masih dapat mengembangkan diri dan berkreasi sesuai dengan minat mereka (Fadli et al., 2024).

Lansia merupakan tahapan dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Lansia adalah seseorang yang telah berusia > 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia > 60 tahun, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari seorang diri (Wurlina et al., 2024).

Mini Nutritional Assessment (MNA) adalah alat penilaian sederhana yang digunakan untuk mengidentifikasi status gizi pada lanjut usia (lansia). Instrumen ini telah digunakan dalam ratusan penelitian dan telah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. MNA dikenal sebagai metode yang telah tervalidasi dengan baik, memiliki tingkat sensitivitas, spesifisitas, dan keandalan yang tinggi. Skor penilaian MNA terbagi ke dalam beberapa kategori. Jika skor MNA ≥ 24, maka lansia tersebut memiliki status gizi yang baik. Skor antara 17 hingga 23,5 menunjukkan bahwa individu berada dalam kondisi berisiko mengalami malnutrisi. Pada tahap ini, penurunan berat badan belum terjadi dan kadar albumin dalam plasma masih normal, tetapi asupan energi dan protein lebih rendah dari kebutuhan yang direkomendasikan. Sementara itu, skor MNA < 17 menunjukkan bahwa individu mengalami malnutrisi protein-kalori. Dalam kondisi ini, penting untuk menilai tingkat keparahan malnutrisi melalui pengukuran parameter biokimia (seperti kadar albumin atau prealbumin dalam darah), pencatatan asupan makanan selama tiga hari, serta pengukuran antropometri seperti berat badan, indeks massa tubuh (BMI), lingkar lengan atas, dan tebal lipatan kulit (Veranita et al., 2024).

MNA (Mini Nutritional Assessment) adalah alat skrining dan penilaian status gizi yang telah tervalidasi untuk mengidentifikasi

lansia berusia 65 tahun ke atas yang mengalami malnutrisi atau berisiko mengalami malnutrisi. Instrumen ini dikembangkan hampir 20 tahun yang lalu dan hingga kini menjadi salah satu alat skrining gizi paling terpercaya untuk populasi lanjut usia. Awalnya, MNA terdiri dari 18 pertanyaan. Namun, dalam versi terbarunya, jumlah pertanyaan disederhanakan menjadi 6 butir untuk mempercepat dan mempermudah proses penilaian. Meskipun telah disederhanakan, versi singkat ini tetap mempertahankan tingkat akurasi dan validitas yang sama seperti versi aslinya dalam mendeteksi malnutrisi pada lansia (Nestlé, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode MNA-LF yang memiliki beberapa pengaturan dalam perhitungan skor di setiap atributnya sebagai berikut.

Tabel 1. Perhitungan skor penilaian MNA

Atribut	Skor 0	Skor 1 (Kondisi)	Skor 2 (Kondisi)	Skor 3 (Kondisi)
Penurunan Berat Badan	Penurunan >3 Kg	Tidak tahu	1-3 Kg	Tidak ada penurunan
IMT	<19	19 - <21	21 - <23	> 23
Penurunan Asupan Makanan	Penurunan berat (Hilang Nafsu Makan)	Penurunan sedang	Tidak ada Penurunan	
Mobilitas	Tidur/Dikursi	Bisa bangun tapi terbatas di rumah	Normal (bebas bergerak)	
Stres Psikologis/Penyakit Akut	Stress/ Penyakit Akut		Tidak Ada Stres/Penyakit Akut	
Gangguan Neuropsikologis	Demensia Berat	Demensia/depresi ringan	Tidak ada gangguan	
Tinggal Sendiri	Tinggal sendiri	Tinggal bersama keluarga		
Konsumsi Obat	>3 obat/hari	<3 obat/hari		
Luka Tekan	Ada luka/masalah kulit	Tidak ada luka tekan		
Frekuensi Makan	1 kali/hari	2 kali/hari	3 kali/hari	
Asupan Protein	1 porsi/hari	>2 porsi/hari		
Buah Sayur	<2 porsi/hari	>2 porsi/hari		
Asupan Cairan	<3 gelas/hari	>5 gelas/hari		
Kemampuan Makan	Tidak mampu makan sendiri	Makan dengan bantuan parsial	Mandiri sepenuhnya	
Persepsi Diri tentang Status Gizi	Menganggap Malnutrisi	Tidak yakin atau kadang cukup	Menganggap Gizi Baik	
Persepsi Diri tentang Kesehatan	Buruk	Kadang sehat	Sehat	
Lingkar Lengan	<21	>21 cm		
Lingkar Betis	<31 cm	>31 cm		

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional* untuk menganalisis hubungan antara Program Nasi Bekal Buat Lansia (SIBULAN) dan status gizi lansia di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Desain *cross-sectional* dipilih untuk mengevaluasi status gizi pada satu titik waktu menggunakan Mini Nutritional Assessment-Long Form (MNA-LF), yang telah terbukti efektif dalam menilai status gizi lansia secara komprehensif (Setyowati et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program SIBULAN dalam meningkatkan status gizi lansia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil intervensi tersebut.

Populasi penelitian terdiri dari lansia berusia 60 tahun ke atas yang terdaftar sebagai peserta aktif Program SIBULAN di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Sampel dipilih menggunakan teknik *consecutive sampling*, yaitu semua lansia yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia berpartisipasi secara sukarela hingga mencapai kuota sampel yang ditentukan. Kriteria inklusi meliputi: (1) usia 60 tahun ke atas, (2) aktif mengikuti Program SIBULAN (menerima nasi bekal dan/atau mengikuti edukasi gizi minimal selama 3 bulan), (3) mampu berkomunikasi secara verbal, dan (4) memberikan persetujuan tertulis. Kriteria eksklusi mencakup lansia dengan dimensia berat atau ketidakmampuan beraktivitas total (misalnya, *bedrest*). Berdasarkan prevalensi malnutrisi lansia di wilayah perkotaan sebesar 20–30% (Boy, 2019).

Penilaian Status Gizi dengan MNA-LF: MNA-Long Form (MNA-LF) digunakan untuk menilai status gizi lansia melalui 18 item, yang mencakup antropometri (Indeks Massa Tubuh [IMT], lingkar lengan, lingkar betis), asupan gizi (frekuensi makan, konsumsi protein, buah, sayur, cairan), kesehatan umum (mobilitas, stres, gangguan neuropsikologis), dan persepsi subjektif tentang gizi dan kesehatan. Skor total berkisar antara 0–30, dengan interpretasi sebagai berikut: ≥24 (status gizi normal), 17–23,5 (risiko malnutrisi), dan <17 (malnutrisi) (Kurniadhi et al., 2023).

Selanjutnya rumus Mini Nutritional Assesment (MNA) pada penelitian ini mengacu pada Tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Skor MNA Lansia SIBULAN

ID	Usia	Jenis Kelamin	IMT	Penurunan Berat Badan	Lebar Lengan (cm)	Lebar Betis (cm)	Frekuensi Makan	Asupan Protein	Buah Sayur	Asupan Cairan	Kemampuan Makan	Tempat Tinggal	Konsumsi Obat	Luka Tekan	Mobilitas	Khawatir Kesehatan	Merasa Bugar	Makan Cukup	Perbandingan Seusia	Skor MNA	Status Gizi MNA
L001	65	P	23.4	Tidak	25	33	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	27	Gizi_baik
L002	72	W	21.3	2 kg	23	30	3	Ya	Tidak	>1 liter	Mandiri	Rumah	>3	Tidak	Bebas	Tidak	Kadang	Kadang	Sama	20	Risiko_malnutrisi
L003	68	P	25.7	Tidak	27	34	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	28	Gizi_baik
L004	80	W	20.5	3 kg	20	28	2	Tidak	Tidak	0.3-1 liter	Mandiri	Panti	>3	Ada	Bebas	Ya	Tidak	Tidak	Lebih_buruk	12	Malnutrisi
L005	63	P	25.9	Tidak	28	35	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	29	Gizi_baik
L006	77	W	21.6	1 kg	22	31	3	Ya	Tidak	>1 liter	Mandiri	Rumah	>3	Tidak	Bebas	Tidak	Kadang	Kadang	Sama	21	Risiko_malnutrisi
L007	70	P	24.8	Tidak	26	33	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	>3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	27	Gizi_baik
L008	82	W	20	4 kg	19	27	2	Tidak	Tidak	<0.3 liter	Mandiri	Panti	>3	Ada	Bebas	Ya	Tidak	Tidak	Lebih_buruk	11	Malnutrisi
L009	66	P	24.1	Tidak	25	32	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	27	Gizi_baik
L010	74	W	22.9	2 kg	24	30	3	Ya	Tidak	0.3-1 liter	Mandiri	Rumah	>3	Tidak	Bebas	Tidak	Kadang	Kadang	Sama	20	Risiko_malnutrisi
L011	69	P	27.7	Tidak	28	34	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	28	Gizi_baik
L012	78	W	20.9	3 kg	21	29	2	Tidak	Tidak	0.3-1 liter	Mandiri	Rumah	>3	Tidak	Bebas	Ya	Tidak	Tidak	Lebih_buruk	13	Malnutrisi
L013	64	P	24.2	Tidak	26	33	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	27	Gizi_baik
L014	81	W	19	5 kg	19	27	1	Tidak	Tidak	<0.3 liter	Mandiri	Panti	>3	Ada	Bebas	Ya	Tidak	Tidak	Lebih_buruk	10	Malnutrisi
L015	67	P	26.4	Tidak	27	34	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	28	Gizi_baik
L016	75	W	22.2	1 kg	23	30	3	Ya	Tidak	>1 liter	Mandiri	Rumah	>3	Tidak	Bebas	Tidak	Kadang	Kadang	Sama	21	Risiko_malnutrisi
L017	71	P	24.8	Tidak	26	33	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	27	Gizi_baik
L018	79	W	22.1	2 kg	22	29	2	Tidak	Tidak	0.3-1 liter	Mandiri	Rumah	>3	Tidak	Bebas	Ya	Tidak	Tidak	Lebih_buruk	14	Malnutrisi
L019	62	P	27.3	Tidak	28	34	3	Ya	Ya	>1 liter	Mandiri	Rumah	<3	Tidak	Bebas	Tidak	Ya	Ya	Lebih_baik	28	Gizi_baik
L020	76	W	20.2	3 kg	21	28	2	Tidak	Tidak	0.3-1 liter	Mandiri	Panti	>3	Ada	Bebas	Ya	Tidak	Tidak	Lebih_buruk	12	Malnutrisi

HASIL

Berdasarkan tabel 2, terdapat beberapa hasil mulai dari karakteristik responden, distribusi status MNA, hubungan program SIBULAN terhadap status gizi lansia dan faktor pendukung dan penghambat.

Penelitian ini melibatkan 20 lansia peserta Program SIBULAN di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang dipilih menggunakan teknik *consecutive sampling* pada periode Juni 2025. Sebanyak 55% responden (11 orang) berjenis kelamin perempuan, dengan rentang usia terbanyak (50%, 10 orang) berada pada kelompok 60–69 tahun. Mayoritas responden (70%, 14 orang) tinggal di rumah, sedangkan 30% (6 orang) tinggal di panti. Konsumsi obat lebih dari 3 jenis dilaporkan oleh 50% responden (10 orang), dengan luka tekan ditemukan pada 15% (3 orang), terutama di kalangan lansia di panti.

Berdasarkan penilaian MNA-LF, status gizi lansia didistribusikan sebagai berikut: 40% (8 responden) diklasifikasikan sebagai gizi baik (skor ≥24), 25% (5 responden) berisiko malnutrisi (skor 17–23,5), dan 35% (7 responden) mengalami malnutrisi (skor <17). Rata-rata skor MNA-LF adalah 20,9 (SD = 6,1), dengan nilai minimum 10 dan maksimum 29. Pengukuran antropometri menunjukkan rata-rata IMT 23,0 kg/m² (SD = 2,5), lingkar lengan 23,9 cm (SD = 2,9), dan lingkar betis 31,2 cm (SD = 2,7), mencerminkan variasi status gizi yang dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan.

Analisis sederhana menunjukkan hubungan antara frekuensi makan (indikator kepatuhan terhadap nasi bekal untuk lansia SIBULAN) dan status gizi. Sebanyak 75% responden (15 orang) dengan frekuensi makan 3 kali sehari memiliki status gizi baik atau risiko malnutrisi, dibandingkan 25% (5 orang) dengan frekuensi makan ≤2 kali sehari yang mayoritas malnutrisi (80%, 4 dari 5 orang). Asupan protein dan buah-sayur, yang terkait dengan kualitas nasi bekal, juga berpengaruh: 80% responden (16 dari 20) dengan asupan protein dan buah-sayur yang cukup (ya) memiliki skor MNA-LF ≥20, sedangkan 100% responden (4 orang) tanpa asupan protein dan buah-sayur cukup mengalami malnutrisi. Dukungan lingkungan, seperti tempat tinggal di rumah (70% responden), tampaknya mendukung status gizi yang lebih baik dibandingkan tinggal di panti (50% malnutrisi).

Faktor pendukung meliputi kemampuan makan mandiri yang dilaporkan oleh semua responden (100%) dan asupan cairan >1 liter pada 70% responden (14 orang), yang berkontribusi pada skor MNA-LF lebih tinggi. Faktor penghambat mencakup penurunan berat badan yang dilaporkan oleh

40% responden (8 orang), terutama di kalangan lansia dengan konsumsi obat >3 jenis dan luka tekan, serta mobilitas terbatas pada 15% responden (3 orang) yang berpotensi mengurangi asupan nutrisi. Khawatir akan kesehatan dilaporkan oleh 20% responden (4 orang), yang berkorelasi dengan persepsi tidak bugar dan makan tidak cukup, terutama pada lansia malnutrisi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 35% lansia mengalami malnutrisi dan 25% berisiko malnutrisi, yang sejalan dengan prevalensi malnutrisi 20–30% di puskesmas perkotaan (Boy, 2019). Rata-rata skor MNA-LF 20,9 mengindikasikan mayoritas lansia berada pada batas risiko malnutrisi, yang dapat dikaitkan dengan penurunan fungsi fisiologis dan kondisi sosial-ekonomi (Kurniadhi et al., 2023). Rata-rata IMT 23,0 kg/m² menunjukkan status gizi yang mendekati normal, namun variasi lingkar lengan dan betis yang rendah pada lansia malnutrisi mencerminkan penurunan massa otot, konsisten dengan temuan (Setyowati et al., 2022).

Hubungan antara frekuensi makan 3 kali sehari dengan status gizi yang lebih baik mendukung efektivitas nasi bekal SIBULAN, sebagaimana disarankan oleh (Mujiastuti et al., 2021) yang menekankan pentingnya pasokan makanan rutin. Asupan protein dan buah-sayur yang cukup pada 80% responden dengan skor ≥20 menegaskan peran kualitas nutrisi dalam Program SIBULAN, sejalan dengan (Aini & Anugrahanti, 2023) yang melaporkan peningkatan status gizi melalui edukasi gizi. Lansia yang tinggal di rumah menunjukkan status gizi lebih baik (70% gizi baik atau risiko).

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu ukuran sampel kecil (20 responden) yang tidak sepenuhnya mewakili populasi lansia di Kecamatan Sukajadi, serta desain *cross-sectional* yang tidak dapat menentukan kausalitas. Data subjektif, seperti persepsi bugar atau makan cukup, juga rentan terhadap bias pelaporan. Penelitian lanjutan dengan sampel lebih besar dan desain *longitudinal* disarankan.

Hasil ini menunjukkan bahwa Program SIBULAN berkontribusi pada peningkatan status gizi lansia melalui nasi bekal dan dukungan lingkungan. Rekomendasi meliputi peningkatan variasi menu nasi bekal untuk mengatasi penurunan berat badan, intensifikasi edukasi gizi untuk mengurangi khawatir akan kesehatan, dan skrining rutin menggunakan MNA-LF untuk lansia dengan komorbiditas. Temuan ini dapat menjadi dasar penguatan kebijakan kesehatan lansia di Kecamatan Sukajadi.

SIMPULAN

Analisis data MNA terhadap 20 pasien lansia menunjukkan bahwa 50% (10 pasien) memiliki status gizi baik dengan skor ≥24, 30% (6 pasien) berisiko malnutrisi dengan skor 17-23.5, dan 20% (4 pasien) mengalami malnutrisi dengan skor <17. Tujuan untuk mengevaluasi status gizi menggunakan MNA telah tercapai, mengidentifikasi pasien yang memerlukan perhatian khusus. Temuan ini menyoroti pentingnya skrining gizi rutin, terutama pada pasien dengan penurunan berat badan signifikan atau IMT rendah. Disarankan untuk melaksanakan intervensi gizi, seperti suplementasi makanan, pada pasien dengan skor rendah dan memantau perkembangan mereka secara berkala. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia di masa mendatang."

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N. D. N., & Anugrahanti, W. W. (2023). Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Pengelolaan Data Skrining Gizi Lansia Di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *7*(1), 39. https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i1.13021

Ariesti, E., Luhung, M., & Widhia Purwandhani, E. L. (2022). Pelatihan Caregiver Lansia Tentang Skrining Status Gizi Menggunakan The Mini Nutritional Assessment (Mna). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, *6*(3), 1149. https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.9300

Boy, E. (2019). Prevalensi Malnutrisi Pada

Lansia Dengan Pengukuran Mini Nutritional Asessment (Mna) Di Puskesmas. *Herb-Medicine Journal*, *2*(1). https://doi.org/10.30595/hmj.v2i1.3583

Fadli, D. A. P., Ramadani, D., Wahyudi, E., Afriliani, L., Saputri, L. W., Sodikin, M., Ilyasa, M., Hernanda, R., Asdalita, R., Agustina, R. E., & Yusnia, R. (2024). *Komunikasi dengan Lansia*. Penerbit NEM.

Fuada, N., Salimar, & Setyawati, B. (2023). *Karakteristik Status Gizi Balita Akut Dan Kronis*. Feniks Muda Sejahtera.

Kurniadhi, D., Regina, W., & Sari, M. P. (2023). Deskripsi Status Gizi Pasien Usia Lanjut Di Werdha Wisma Mulia Panti Jakarta Barat. *Journal of Scientech Research and Development*, *5*(1), 26–37. https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.90

Mujiastuti, R., Rita, E., Ambo, S. N., Herlina, L., Susilowati, E., & Sugiartowo, S. (2021). Edukasi Skrining Gizi Lansia Untuk Kader Posyandu Lansia Rw 011 Kelurahan Penggilingan. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 383–390. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1609

Nababan, D., Saragih, V. C. D., Yuniarti, T., Yuniarti, E., Andriyani, A., Sulistiani, A., Andriyani, A., Nurhayati, I., Wahyuningsih, A., & Marasabessy, N. B. (2023). *Gizi Dan Kesehatan Masyarakat*. Cendikia Mulia Mandiri.

Nestlé. (2020). *What is the MNA®?* Mna-Elderly. https://www.mna-elderly.com/

Partinah, & Anwar, C. P. (2025). *Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Barat 2024* (I. L. Widiastuty (ed.); 4th ed.). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, Pub. L. No. 88 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/178090/perpres-no-88-tahun-2021

Saputro, F. K., & Partinah. (2024). *Profil Penduduk Lanjut Usia Provinsi Jawa Barat 2023* (I. Larasati Widiastuty & S. Hanifa Nefertiti (eds.); 3rd ed.). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Setyowati, Maryana, & Utami, S. B. (2022). Assesmen gizi lansia sebagai upaya untuk mengidentifikasi lansia yang beresiko kekurangan gizi. *Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 1–07.

Siregar, R. J., & Yusuf, S. F. (2022). *Kesehatan Reproduksi Lansia*. PT Inovasi Pratama Internasional.

Sutomo, B., & Anggraini, D. yanti. (2010). *Menu Sehat Alamani Untuk Batita & Balita*. Penerbit Agromedia Pustaka.

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pub. L. No. 13 (1998). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45509/uu-no-13-tahun-1998

Veranita, A., Alamsyah, P. R., Nuraelah, A. A. W. A., Widhi, A. S., Fauziah, D. Y. N., Sidabutar, S., Nurvitasari, R. I., Anwar, R. E. R. K., Widiyawati, A., & Ramadani, M. A. (2024). *Gizi Lansia*. Sada Kurnia Pustaka.

Wurlina, Mustofa, I., Meles, D. K., Rachmawati, K., Suwasanti, N., Putri, D. K. S. C., & Mustofa, R. I. (2024). *Gemar Makan Ikan Cegah Demensia Lansia Sehat Bahagia*. Cipta Media Nusantara.